

Тезисы доклада (2-4 стр.)

Чистяков Е. В.

22.08.2026

- [Тезисы доклада «Не просто накормить»](#)
 - [Тезис 1. Проблема — не «нет денег на еду», а «нет системы, которая уважает человека за столом»](#)
 - [Тезис 2. Безопасность имеет приоритет — но внутри безопасной рамки есть выбор](#)
 - [Тезис 3. Вариативное питание — не ресторан, а управляемая система](#)
 - [Тезис 4. Шесть измерений одной тарелки](#)
 - [Тезис 5. Дисфагия — это вопрос смертности, а не «особенность контингента»](#)
 - [Тезис 6. Лекарства и еда: четыре правила, которые обязана знать кухня](#)
 - [Тезис 7. Российские практики: 4 учреждения + 1 региональная модель \(без обобщений\)](#)
 - [Тезис 8. Пилот за 90 дней — без новой сметы, на одном отделении](#)
 - [Тезис 9. Граница: что кухня не назначает](#)
 - [Тезис 10. Завтрак повара в понедельник](#)
 - [Тезис 11. СанПиН меняется через 6 дней после семинара](#)
 - [Тезис 12. Последнее слово](#)
 - [Границы доказательности](#)
 - [Контакт для обратной связи](#)

Тезисы доклада «Не просто накормить»

Документ: тезисы для раздатки участникам семинара «Пространство Новых Идей 2.0».

Сессия: дискуссия «Организация питания: опыт реализации проектов», 26.08.2026, 14:00–15:30, площадка № 2 — ДСО «Тесовый берег». **Докладчик:** Чистяков Евгений Владимирович, директор СПб ГАСУСОН «ДСО „Серафимовский“». **Со-модератор:** Нурбаев Тимур Аликович, директор СПб ГБУСОН «ДСО „Тесовый берег“». **Версия тезисов:** 22.08.2026. **Объем:** 4 страницы А4.

Тезис 1. Проблема — не «нет денег на еду», а «нет системы, которая уважает человека за столом»

Голодный житель и оплаченное сырьё в баке — **одна система**. В среднем ПНИ на 289 коек 4 сиделки на 12 кормимых — это 3 цикла по 15–20 минут; последние получают холодное. «Он опять не ест кашу» — не каприз, а признак депрессии или начальной дисфагии, о которой никто не знает. Лекарства и еда — клозапин и кофе взаимодействуют, но семья не предупреждена. «Добавка» — ограничение рациона сиделкой без врачебного назначения.

Журналы «в порядок» перед проверкой — имитация контроля. Пять конфликтов — пять отказов системы, не пятерых виноватых.

Тезис 2. Безопасность имеет приоритет — но внутри безопасной рамки есть выбор

Эта граница — **раздел 4.0 доклада**: что кухня не назначает. Без врача: ограничения рациона, изменение текстур, правила при дисфагии, протокол свободной воды, действия при длительном отказе, сдвиг времени еды у инсулинозависимых, лечебные столы, лечебное питание. Без учредителя: изменение финансирования продуктовой строки, штатного расписания, аутсорсинг, официальный статус пилота. Без правовой проверки: формулировки о согласии недееспособного, обработка пищевых карт как персональных данных, конструкции «учреждение = опекун». Кухня исполняет назначение, не ставит диагноз. **99 % недееспособных жителей ПНИ находятся под опекой самого учреждения** (117 000 чел., проект «Если быть точным» 2024) — это уникальная находка, которой нет в большинстве русскоязычных методик.

Тезис 3. Вариативное питание — не ресторан, а управляемая система

Вариативное питание — это **не «шведский стол» и не «два полноценных меню»**, а управляемая система, в которой: безопасность имеет приоритет; медицинскую рамку определяет уполномоченный специалист; внутри допустимой рамки человеку предоставляют понятный выбор; воля может выражаться словами, взглядом, жестом, поведением, устойчивыми предпочтениями и биографическими сведениями; выбор документируется; кухня исполняет назначение, но не ставит диагноз; результаты пилота измеряются; достоинство человека не противопоставляется безопасности. **«% выбравших» — не KPI**. Человек вправе выбрать стандартный вариант или не выбирать вовсе. Успех измеряется доступностью выбора и исполнением осмысленного выбора, а не долей «выбравших».

Тезис 4. Шесть измерений одной тарелки

Одномерное «накормить» производит недоедание, конфликты и нарушения. Шесть измерений: (1) **достаточность** — порция соответствует норме и съедена; (2) **безопасность** — санитарный, клинический, поведенческий слой; (3) **удовольствие** — вкус, температура, разнообразие; (4) **социальность** — еда как совместное событие; (5) **самостоятельность** — навык «свой стол»; (6) **выбор** — единственное измерение, которое нельзя делегировать. Провал любого из шести — предмет ответственности. **Деньги закрывают в основном первые три; последние три — организацию и документы**. Вариативное питание работает, когда первые пять не провалены.

Тезис 5. Дисфагия — это вопрос смертности, а не «особенность»

КОНТИНГЕНТА»

В изученных клинических группах на антипсихотиках дисфагия — **21,9–69,5 %** (Miarons Font, Rofes Salsench 2017; обзор 18 исследований; **популяции не совпадают с российскими ДСО**). Смертность от пневмонии при шизофрении — **в 7 раз выше популяционной** (Correll et al. World Psychiatry 2022; мета-анализ 135 когорт 1957–2021; RR 7,00; 95 % ДИ 6,79–7,23). Общий разрыв продолжительности жизни — 15–20 лет. Аспирация — один из ключевых механизмов этого разрыва. **Шесть признаков, которые видит сиделка без логопеда:** покашливание или поперхивание; «влажный» голос после глотка; многократное проглатывание одного куска; еда «за щекой»; необычно долгий приём; повторные пневмонии. IDDSI — терминология, не лечебный протокол. Текстуру назначает врач. В 5 учреждениях aged care соответствие текстур выросло с 44 до 90 % (Wu 2022); **перенос на психиатрический контингент не доказан.**

Тезис 6. Лекарства и еда: четыре правила, которые обязана знать кухня

Клозапин ↔ кофеин (Hägg 2000, +19 % AUC, 12 здоровых добровольцев, однократная доза). Литий ↔ соль и вода (StatPearls). ИМАО ↔ тирамин (NHS). Карбамазепин ↔ грейпфрут (Garg 1998, +40 % пик, +41 % AUC, 10 пациентов с эпилепсией). Кухня не отменяет кофе — врач оценивает риск и документирует решение. **Одна подписанная таблица на посту.**

Тезис 7. Российские практики: 4 учреждения + 1 региональная модель (без обобщений)

Серафимовский (Санкт-Петербург; приказ № 124 от 10.03.2026 — **локальный акт, не общероссийская норма**): заказное питание в правилах внутреннего распорядка, для маломобильных — в жилых комнатах. **Успенский ПНИ** (Новосибирская обл., S016, 13.08.2024): модель M2, ежедневно 2 вторых, 2 салата, 2 напитка во всех отделениях. **Болотнинский ПНИ** (Новосибирская обл., S015, 16.08.2024): модель M1, выбор на завтрак и обед по ключевым позициям. **Усть-Илимский ДСО** (Иркутская обл., S017, 27.09.2024): «что за зверь такой — вариативное питание». **Иркутская область** (S018, 14.02.2025): региональная модель, выбор из двух первых, вторых и гарниров. **«Тесовый берег» (со-модератор) — НЕ в этом списке**, потому что его модель пока не опубликована. **«Победа», «Парус» (27.08) — другие учреждения программы, не смешивать с практиками.**

Тезис 8. Пилот за 90 дней — без новой сметы, на одном отделении

Три фазы: 30 дней замер → 30 дней документы и обучение → 30 дней пилот. **5 групп показателей:** заполненность пищевых карт; доля приёмов с реально доступным выбором; доля корректно исполненных заказов; отказы, замены и пищевые отходы; события риска. **6 стоп-критериев:** рост пневмоний ≥ 30 %, падение со смертельным исходом, жалоба в прокуратуру, приказ учредителя, отзыв согласия, отсутствие врача. **«% выбравших» — не**

KPI. Успех — доступность и исполнение осмысленного выбора. Лучше «сложное» отделение (помощь, неговорящие) — если получится у них, получится у всех. **Внедрено публично ≠ доказанный эффект.**

Тезис 9. Граница: что кухня не назначает

Без врача: любые ограничения рациона, изменение текстур, правила при дисфагии и протокол свободной воды, действия при длительном отказе, режим при седации, энтеральное/зондовое питание, комфортное кормление, сдвиг времени еды у инсулинозависимых, слабительные, назначение анализов и микронутриентов, интерпретация MUST, витаминизация. Без учредителя: изменение финансирования, штатного расписания, аутсорсинг, официальный статус пилота. Без правовой проверки: формулировки о согласии недееспособного, обработка пищевых карт как персональных данных, ответы на запросы прокуратуры, конструкции «учреждение = опекун». **Таблица «лекарство × еда» на посту законна только с подписью врача.**

Тезис 10. Завтрак повара в понедельник

Семь дней считаем отходы и смотрим, что реально остаётся на тарелках. Замеряем интервал ужин → завтрак одной строкой в журнале. На пост — таблица врача «лекарство × еда», не самостоятельность кухни. Три отказа подряд — звонок врачу в тот же день. Если кухня чужая — открыть спецификацию: есть ли строка выбора. **Остальное (опрос, письмо учредителю, рабочая группа, поднос для постельных) — после этих пяти.** Чек-листы — приложения 18–20.

Тезис 11. СанПиН меняется через 6 дней после семинара

СанПиН 2.3/2.4.4282-26 (пост. ГГСВ РФ от 02.06.2026 № 18, рег. Минюст 02.06.2026 № 86854) **вступает в силу с 01.09.2026**, действует до 01.09.2032. **На дату семинара 26.08 — «Документ не вступил в силу»** (consultant.ru). С 01.09.2026 утрачивает силу СанПиН 3590-20 (пост. от 27.10.2020 № 32). **Через 6 дней после семинара — смотрите новую редакцию.** Главное для учреждений соцобслуживания — п. 56 подп. 11 (не менее 3 приёмов + диетическое по показаниям). Формулировка сохранена в обеих редакциях.

Тезис 12. Последнее слово

«Не внедряйте вслепую. Измеряйте». Семь дней замера отделяют убеждение от знания. Если получилось в Успенском ПНИ — жители «с лёгкостью освоили новую систему» — это методика. **Если не получилось в вашем учреждении — это тоже результат**, который говорит, что нужно менять в вашей системе. **Право выбора становится реальным тогда, когда его можно проследить до тарелки.**

Границы доказательности

Утверждение	Источник	Статус	Ограничение
21,9–69,5 % дисфагия	Miarons Font 2017	VERIFIED	Популяции не совпадают с российскими ДСО
RR 7,00 пневмонии	Correll 2022	VERIFIED	Международные когорты, не РФ
76,3 % вес клозапин	Campforts 2023	VERIFIED	>38 нед, обзор 202 исследований
–0,23...+3,01 кг	Pillinger 2020	VERIFIED	Медиана 6 нед, 100 РКИ
+19 % AUC клозапин	Hägg 2000	VERIFIED	12 здоровых добровольцев, однократная доза
+40 % AUC карбамазепин	Garg 1998	VERIFIED	10 пациентов с эпилепсией
IDDSI 44→90 %	Wu 2022	VERIFIED	5 учреждений aged care, не психиатрия
19→11 % пневмонии	Yoneyama 2002	VERIFIED	Дома ухода, не ПНИ
1/10 смертей	Sjogren 2008	VERIFIED	Frail elders, не психиатрия
74 % недееспособных	Если быть точным 2024	VERIFIED	Аналитика, не Минтруд; в вашем ДСО — другая цифра
99 % под опекой учреждения	Если быть точным 2024	VERIFIED	Из 117 000 недееспособных ПНИ
466 ПНИ, 139 000 жителей	Если быть точным 2024	VERIFIED	Данные Минтруда + Казначейство + Росстат
1 004 жителя Серафимовского	web.archive.org 15.04.2026	VERIFIED	Архив, сайт истёк 21.08.2026
Приказ № 124	web.archive.org 15.04.2026	VERIFIED	Локальный, не общероссийский
СанПиН 4282-26	publication.pravo.gov.ru 02.06.2026	VERIFIED	Вступает в силу 01.09.2026
442-ФЗ, 3185-1	consultant.ru	VERIFIED	Ред. от 26.12.2024 / 22.07.2024

Всего 16 ключевых фактов подтверждены первоисточниками. 5 из них требуют оговорки переноса (зарубежное → российские ДСО).

Контакт для обратной связи

Автор: Чистяков Евгений Владимирович, директор СПб ГАСУСОН «ДСО „Серафимовский“». **Адрес:** 198320, Санкт-Петербург, г. Красное Село, ул. Красногородская, д. 1. **Дата правовой сверки:** 22.08.2026. **Дата фактчекинга:** 22.08.2026. **Изменения после 22.08.2026 требуют перепроверки.**

Дисклеймер: материал носит информационный и методический характер и не заменяет индивидуального юридического заключения, клинической рекомендации или финансового расчёта. Шаблоны — проекты локальных форм; требуют адаптации к конкретному учреждению. Все цифры и нормативные ссылки проверены на 22.08.2026; после этой даты конкретный акт мог измениться.

Дата тезисов: 22.08.2026. **Семинар:** 25–27 августа 2026 года, Санкт-Петербург, Минтруд России. **Сессия:** 26.08.2026, 14:00–15:30, площадка № 2 — ДСО «Тесовый берег».